ONEMA-POP-030 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-030 — Monitoramento de Pessoa com DPOC e
Triagem de Exacerbação Aguda

1. Identificação institucional

REVISÃO TÉCNICA DO RT

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a abordagem de monitoramento de pessoa com dpoc e triagem de exacerbação aguda em atendimento domiciliar ou digital, conforme a pertinência. Não substitui avaliação médica ou atendimento de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e treinado. Monitoramento de DPOC estável e triagem de exacerbação; intervenções farmacológicas conforme prescrição. Contraindicado manter cuidado eletivo quando presentes sinais de emergência ou quando o procedimento exceder a competência/estrutura disponível.

4. Materiais e fornecimento

Enfermeiro: oxímetro, termômetro, estetoscópio, aparelho de pressão; paciente: inaladores prescritos, espaçador se indicado, plano de ação.

5. Avaliação e preparo

Dispneia basal versus atual, tosse, escarro, febre, uso de resgate, SpO2 basal, oxigênio domiciliar e comorbidades.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar diagnóstico conhecido, plano terapêutico e valores habituais de saturação.

2. Investigar aumento de dispneia, volume/purulência do escarro, febre, dor torácica e confusão.

3. Avaliar frequência respiratória, esforço ventilatório, estado mental e oximetria quando presencial.

4. Revisar técnica do inalador com demonstração e retorno demonstrativo, sem alterar doses.

5. Identificar uso de oxigênio domiciliar e conferir prescrição e segurança contra incêndio; não ajustar fluxo

arbitrariamente.

6. Se exacerbação sem sinais de emergência, orientar contato médico no mesmo dia conforme gravidade e plano

existente.

7. Se dispneia intensa, cianose, confusão, incapacidade de falar ou deterioração, acionar SAMU 192.

8. Registrar sinais, linha de base, intervenções, encaminhamento e confirmação do cuidado.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Insuficiência respiratória suspeita, dor torácica, alteração de consciência ou deterioração rápida: emergência.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar técnica inalatória, vacinação, cessação tabágica e sinais de exacerbação.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa e histórico, avaliação e sinais vitais pertinentes, achados objetivos, cada etapa executada e resposta, orientações, escalonamento/contatos, plano de retorno, identificação e assinatura do enfermeiro. Fotos somente com consentimento específico.

10. Referências rastreáveis

 GOLD — Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD — https://goldcopd.org/

NOTA DE CONTROLE: referências identificadas e parcialmente conferidas; adequação à legislação brasileira, protocolos locais e instruções de fabricante deve ser analisada pelo RT.